Presidio Ospedaliero Monte Alberino
S.C. Radiodiagnostica
Direttore: Dott. Renato Gallesio

Corso Valsesia 41
10149 Torino
Segreteria tel. 011 4092217
radiologia@montealberino.example.it

REFERTO DI RADIOLOGIA

RX Torace in due proiezioni (PA e LL)

DATI DEL PAZIENTE

Paziente:	**Giuseppe Lanzetta**	Data di nascita:	**21/03/1958**
Codice fiscale:	**LNZGPP58C21L219A**	Medico richiedente:	**Dott.ssa Laura Bertone**

N. accesso:	RX25-0147736	Data esame:	14/05/2025 ore 09:12	Data referto:	15/05/2025
Prestazione:	87.44.1 - RX torace standard	Regime:	Esterno SSN	Sala diagnostica:	DR 2 - piano terra

QUESITO DIAGNOSTICO

Tosse produttiva e febbricola da circa dieci giorni, non responsiva a terapia sintomatica. Noto BPCO in ex fumatore.

TECNICA

Radiogrammi del torace in proiezione postero-anteriore e laterale sinistra, eseguiti in ortostatismo e in inspirazione profonda. Esame tecnicamente adeguato. Non disponibili precedenti per confronto.

DESCRIZIONE

Area di addensamento parenchimale a margini sfumati in sede basale destra, proiettivamente riferibile al segmento laterale del lobo medio, con broncogramma aereo nel contesto.
Accentuazione diffusa del disegno interstiziale e iperdiafania delle basi, reperti compatibili con la nota broncopneumopatia cronica ostruttiva.
Seni costofrenici liberi bilateralmente. Ilo destro lievemente ingrandito, verosimilmente di natura vascolare-reattiva.
Ombra cardiaca nei limiti per morfologia e dimensioni (indice cardio-toracico 0,48). Aorta toracica lievemente ectasica e calcifica a livello dell'arco. Strutture ossee in esame senza alterazioni focali di rilievo.

CONCLUSIONI

Quadro radiografico compatibile con focolaio broncopneumonico basale destro in paziente con BPCO.
Si consiglia controllo radiografico a distanza di 4-6 settimane dal termine della terapia antibiotica, per documentare la risoluzione del reperto.

Il Medico Radiologo
Dott. Paolo Cerutti

Torino, 15/05/2025

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.